

TEMA 7.12 • NEFROLOGÍA

Casos de Glomerulonefritis

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El estudio de las **glomerulonefritis (GN)** puede parecer complejo debido a las múltiples clasificaciones existentes. Para efectos del examen, es fundamental categorizarlas según su comportamiento inmunológico (complemento e inmunofluorescencia) y su presentación clínica.

1. Clasificación según Complementemia

Esta es una de las clasificaciones más "preguntables". Dividimos las GN en aquellas que consumen complemento (hipocomplementémicas) y las que mantienen niveles normales (normocomplementémicas).

TABLA 7.12.1: GN HIPOCOMPLEMENTÉMICAS VS GN NORMOCOMPLEMENTÉMICAS

GN HIPOCOMPLEMENTÉMICAS	GN NORMOCOMPLEMENTÉMICAS
GN Post-estreptocócica (GNAPE) y otras post-infecciosas.	Nefropatía por IgA (Enfermedad de Berger).
Lupus Eritematoso Sistémico (Lupus Eritematoso Sistémico).	Vasculitis de vaso pequeño (ANCA +).
GN Mesangiocapilar (Membranoproliferativa).	Enfermedad por anticuerpos anti-MBG (Goodpasture).
Crioglobulinemia (asociada a Hepatitis C).	Púrpura de Schönlein-Henoch.
Endocarditis bacteriana.	

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La lista de las **hipocomplementémicas** es corta y de alto rendimiento. Si un paciente tiene un síndrome nefrítico y el complemento está bajo, el diagnóstico diferencial se reduce drásticamente a **GNAPE, Lupus, Mesangiocapilar o Crioglobulinemia.**

2. Clasificación según Inmunofluorescencia (IF)

La biopsia renal con inmunofluorescencia permite identificar el patrón de depósito de las proteínas inmunes:

- **Patrón Lineal:** Característico de la **Enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular (MBG)** o Síndrome de Goodpasture. Los anticuerpos se depositan de forma continua a lo largo de la membrana.
- **Patrón Granular:** Indica depósito de complejos inmunes en "grumos".
- *Si brilla para IgG: Pensar en GNAPE o Nefropatía Lúpica.*
- *Si brilla para IgA: Pensar en Enfermedad de Berger o Púrpura de Schönlein-Henoch.*
- **Patrón Pausi-inmune:** Existe escaso o nulo depósito de complejos inmunes (la IF se ve "oscura"). Es el sello de las **Vasculitis de vaso pequeño** (Granulomatosis con Poliangeítis o Wegener, Poliangeítis Microscópica y Churg-Strauss).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de las "Medias Lunas" (Crescéntica): En la microscopía óptica, una GN grave muestra proliferación de células fuera de los capilares glomerulares (extracapilares), formando una estructura en forma de media luna que comprime el ovillo capilar. Esto es característico de las **Glomerulonefritis Rápidamente Progresivas (GNRP).**

3. Principales Entidades Clínicas

Nefropatía por IgA (Enfermedad de Berger)

Es la glomerulonefritis más frecuente a nivel mundial. - **Clínica:** Típicamente presenta **hematuria macroscópica recurrente.** - **Relación con infecciones:** Los brotes ocurren **durante** una

infección respiratoria (sinperiodística), a diferencia de la post-estreptocócica que tiene un periodo de latencia. - **Complemento:** Siempre normal.

GN Post-estreptocócica (GNAPE)

Es la causa más común de **síndrome nefrítico** agudo en niños. - **Clínica:** Edema, hipertensión y hematuria ("orina color café"). - **Periodo de latencia:** Ocurre 1 a 2 semanas después de una faringitis o 3 a 4 semanas tras una infección cutánea (impétigo). - **Complemento:** C3 disminuido (se normaliza en 6-8 semanas). - **Tratamiento:** Principalmente de soporte (manejo de la sobrecarga hídrica con diuréticos).

GN Mesangiocapilar (Membranoproliferativa)

- **Importancia:** Es hipocomplementémica. - **Clínica:** Muy variada, puede presentarse como síndrome nefrítico, nefrótico o incluso un **síndrome nefrítico-nefrotico (impuro).**

Crioglobulinemia

- **Asociación clave:** Altamente relacionada con la **Hepatitis C.** - **Clínica:** Tríada de Meltzer (púrpura palpable, artralgias y debilidad). Afecta zonas frías (nariz, orejas, dedos) porque las crioglobulinas precipitan con el frío. - **Laboratorio:** Hipocomplementemia marcada.

Vasculitis de Vaso Pequeño

Incluye la Poliangeítis Microscópica (PAM), Granulomatosis con Poliangeítis (Wegener) y el Síndrome de Churg-Strauss. - **Clínica:** Compromiso sistémico (mononeuritis múltiple, rash, artralgias). - **Renal:** Suelen presentarse como una **GN Rápidamente Progresiva** con falla renal severa y presencia de medias lunas en la biopsia. - **IF:** Pausi-inmune.

4. Síndrome Riñón-Pulmón

Se define por la coexistencia de glomerulonefritis (usualmente rápidamente progresiva) y hemorragia alveolar (hemoptisis).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante un **Síndrome Riñón-Pulmón**, los principales diagnósticos diferenciales son: 1. **Enfermedad Anti-MBG (Goodpasture):** El más clásico. 2. **Vasculitis ANCA:** (Wegener y PAM). 3. **Lupus Eritematoso Sistémico:** Menos frecuente pero posible.

5. Análisis de Caso Clínico (Perla EUNACOM)

- Imagina un paciente con:
- Poliangeítis microscópica previa.
- Hematuria, hipertensión y edema (Síndrome Nefrítico).
- Creatinina de 5.0 (Falla renal severa).
- Tos y hemoptisis (Compromiso pulmonar).
- **¿Qué podemos concluir?**
- Es un **Síndrome Riñón-Pulmón.**
- Clínicamente es una **GN Rápidamente Progresiva** (por la velocidad de elevación de la creatinina).
- La biopsia mostrará **Medias Lunas** (GN crescéntica).
- La inmunofluorescencia será **Pausi-inmune.**
- El complemento será **Normal** (característico de las vasculitis).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que un mismo paciente puede tener varios "apellidos" diagnósticos: un diagnóstico clínico (Síndrome Nefrítico), un diagnóstico evolutivo (Rápidamente Progresiva), un diagnóstico histológico (Crescéntica) y un diagnóstico etiológico (Vasculitis).

Insuficiencia Renal Aguda Examen de Orina: Interpretación**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 22 años con hematuria macroscópica recurrente que aparece durante infecciones respiratorias altas. Creatinina normal. Complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Casos de Glomerulonefritis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Nefropatía por IgA: hematuria DURANTE infección viral, adolescente, complemento normal, sin falla renal.
- Granulomatosis de Wegener: sinusitis crónica + artralgia + GNRP + síndrome nefrítico en adulto joven.
- Lupus: mujer joven + síntomas sistémicos + GN hipocomplementémica + cilindros eritrocitarios.
- GNAPE: niño + amigdalitis 2 semanas antes + síndrome nefrítico + complemento bajo.
- PAM: mujer mayor + cuadro sistémico + crisis hipertensiva + GNRP (creatinina muy alta).
- GN mesangiocapilar vs IgA: clínica similar pero mesangiocapilar es hipocomplementémica.
- Un mismo paciente puede tener múltiples diagnósticos nefrológicos simultáneamente.
- La biopsia renal es la que da el diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CASOS DE GLOMERULONEFRITIS)**PREGUNTA 1**

Hombre de 22 años con hematuria macroscópica recurrente que aparece durante infecciones respiratorias altas. Creatinina normal. Complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) GNAPE
- ☐ B) GN mesangiocapilar
- ☐ C) Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger)
- ☐ D) Lupus eritematoso sistémico
- ☐ E) Vasculitis de vaso pequeño

PREGUNTA 2

Niño de 6 años presenta edema palpebral, hipertensión y orina oscura 10 días después de una faringoamigdalitis. Complemento C3 bajo. Creatinina de 0.9 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- ☐ A) GNAPE. Biopsia renal urgente
- ☐ B) GNAPE. Soporte y observación sin biopsia
- ☐ C) Nefropatía por IgA. Corticoides
- ☐ D) Lupus. Estudio con ANA
- ☐ E) SHU. Hemograma urgente

PREGUNTA 3

Mujer de 25 años con alopecia, úlceras orales, artralgia y hematuria dismórfica con creatinina de 3.2 mg/dL. Complemento C3 y C4 bajos. ANA positivos. ¿Cuál es el diagnóstico?

- ☐ A) GNAPE
- ☐ B) Crioglobulinemia
- ☐ C) Nefritis lúpica
- ☐ D) Granulomatosis de Wegener
- ☐ E) Nefropatía membranosa

RESUMEN: CASOS DE GLOMERULONEFRITIS

Esta clase presenta seis casos clínicos de glomerulonefritis para integrar los conceptos aprendidos. Caso 1: niño 13 años con hematuria durante resfrío, sin falla renal ni síndrome nefrítico, con complemento normal = nefropatía por IgA (enfermedad de Berger). Caso 2: hombre 27 años con sinusitis crónica, artralgia, hematuria dismórfica, creatinina 5.5, HTA y edema = granulomatosis de Wegener (GNRP + síndrome nefrítico). Caso 3: mujer 20 años con artralgia, fiebre, hematuria dismórfica, creatinina 2.1, cilindros eritrocitarios, complemento bajo = lupus eritematoso sistémico. Caso 4: niño 7 años con amigdalitis hace 2 semanas, síndrome nefrítico completo, creatinina 1.3, complemento bajo = GNAPE. Caso 5: mujer 65 años con artralgia, crisis hipertensiva, creatinina 6 = poliangeítis microscópica (PAM). Caso 6: hombre 20 años con hematuria, orinas espumosas, recurrente, complemento bajo = GN mesangiocapilar (no IgA porque es hipocomplementémica).